

INFECÇÕES DE PELE E PARTES MOLES



ROTINA CLÍNICA

Material bônus

INTRODUÇÃO

- As infecções bacterianas da pele e partes moles são muito frequentes na prática clínica.
- A **celulite** e **erisipela** são infecções cutâneas que se desenvolvem a partir da entrada de bactéria por soluções de continuidade e quebra da barreira cutânea.
- Tais condições resultam em altas taxas de **morbidade** e em **altos custos** financeiros para o mundo.
- Nos Estados Unidos, ocorreram mais de 600.000 hospitalizações em 2010, representando 3,7% de todas as admissões de emergência.



ROTINA CLÍNICA

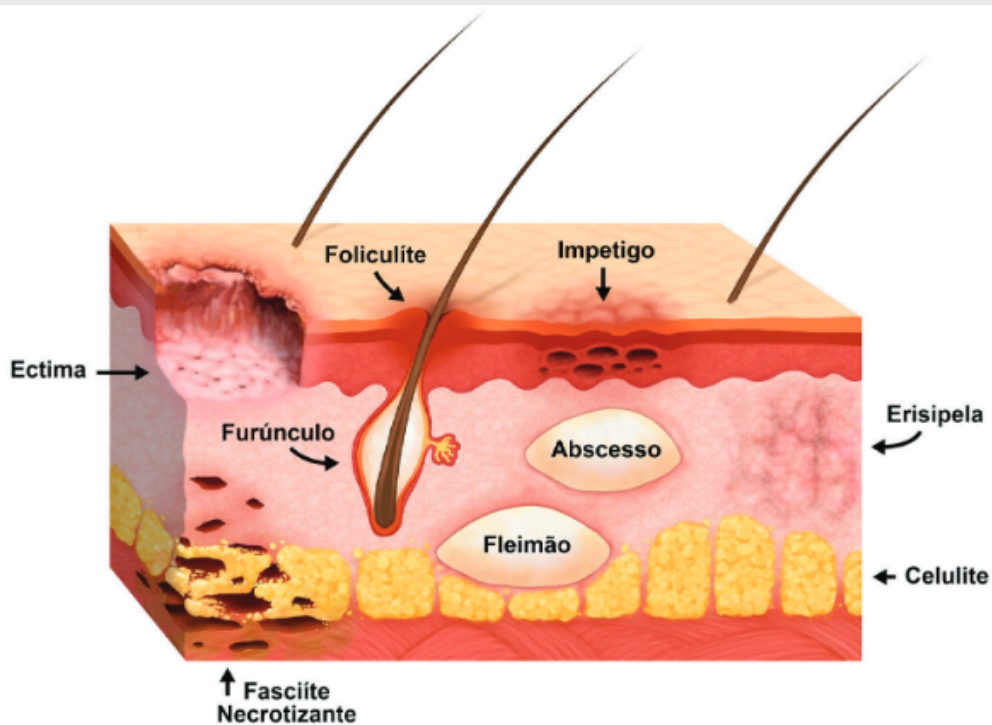


Imagem retirada de: Infecções bacterianas superficiais cutâneas - SBP.



ROTINA CLÍNICA

INTRODUÇÃO

- **Fatores predisponentes para infecções cutâneas:**

Insuficiência venosa (mais frequente fator de risco).

Linfedema.

Doença vascular periférica.

Diabetes.

Obesidade.

Tinea pedis.

Úlceras de membros inferiores.

Trauma local.

Picada de inseto.



CELULITE

- A celulite é causada por uma grande variedade de microorganismos, mas a maioria dos casos é por *Streptococcus pyogenes* ou *Staphylococcus aureus* (patógeno mais frequente).
- Na celulite, ocorre envolvimento da **derme mais profunda** e da **gordura subcutânea**.
- O diagnóstico é **clínico!** No exame físico, evidenciamos **dor, hiperemia, edema e calor** na região acometida, sendo os **membros inferiores** o local mais comum. Em geral, não é possível determinar com exatidão os limites entre tecido acometido e tecido são.



CELULITE

- Podem ocorrer manifestações sistêmicas, incluindo **febre** e **calafrios**.
- Usualmente, os exames laboratoriais não são necessários para o diagnóstico. **Hemograma** e **Proteína C reativa (PCR)** são os mais relevantes, sendo evidenciado, em geral, leucocitose e elevação de PCR.
- Hemoculturas apresentam **baixa positividade** (inferior a 4 ou 5%), sendo recomendadas apenas em pacientes com sintomas de **sepse** e **febre**.

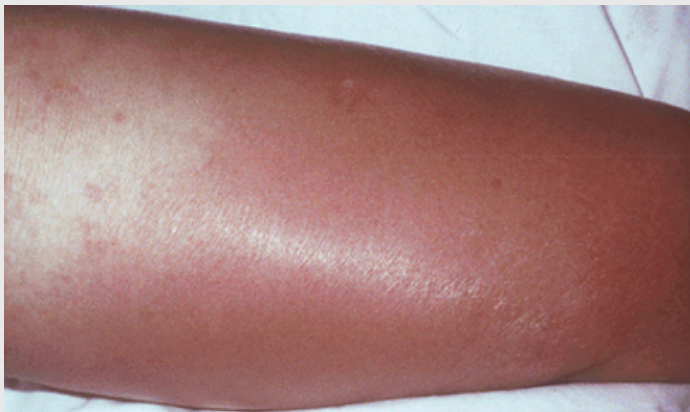


CELULITE NA FACE

- Nesses casos, é fundamental a diferenciação entre um quadro de **celulite pré-septal** (infecção de tecidos perioculares anteriores ao septo orbital) e **celulite pós-septal ou celulite orbitária** (infecção posterior ao septo e, portanto, mais grave).
- Para diferenciação clínica, devemos buscar ativamente a presença de **sinais de alarme** (oftalmoplegia, diplopia, proptose/exoftalmia, dor à movimentação ocular, redução da acuidade visual e quemose).
- Recomenda-se solicitação de **TC de face/seios da face e órbita com contraste**.



CELULITE



Imagens retiradas de: Infecção de pele e partes moles - CREMESP 2013.



ROTINA CLÍNICA

ERISPELA

- No caso de erisipelas, a maioria das infecções é por estreptococos beta-hemolíticos.
- Ocorre envolvimento de **derme e da rede linfática superficial**.
- O diagnóstico é **clínico**! Evidenciamos lesões que se elevam além do nível da pele, com uma **clara linha de demarcação** entre o tecido envolvido (edema, calor, rubor, hiperemia e até presença de bolhas em certos casos) e o tecido não envolvido.
- Manifestações sistêmicas e alterações laboratoriais são similares às da celulite (veja página 6 deste material).



ERISPELA

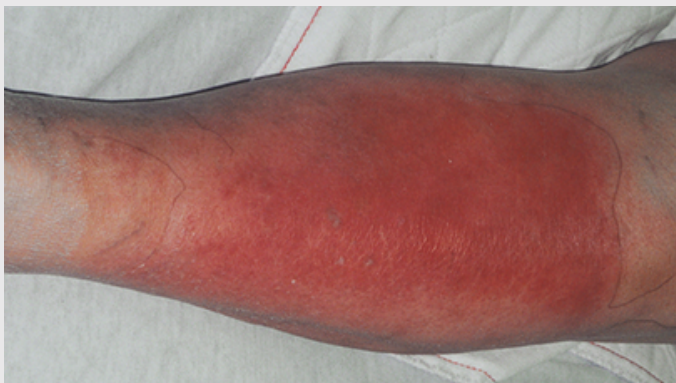


Imagens retiradas do acervo próprio do
Rotina Clínica.



ROTINA CLÍNICA

ERISIPELA



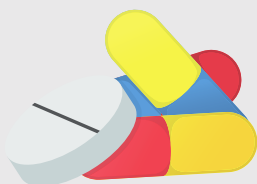
Imagens retiradas de: Acute cellulitis and erysipelas in adults: Treatment - UpToDate



ROTINA CLÍNICA

ABORDAGEM

- Existe uma decisão **muito importante** a ser tomada na abordagem das infecções de pele e partes moles, no que se refere ao seu trabalho como generalista, seja na **UPA, PS ou UBS**.
- E qual é essa decisão? **Internar ou não** o paciente para ser realizada **antibioticoterapia parenteral**.
- A literatura cita que a maioria dos pacientes apresenta quadros leves que podem ser tratados com antibiótico oral.



ABORDAGEM

- O que devemos avaliar: presença de sinais de resposta inflamatória sistêmica (taquicardia, taquipneia, hipotensão), alteração mental (confusão mental) ou eritema com progressão rápida, ou ainda mais, se há preocupação quanto à possibilidade de infecção de tecidos profundos.
- Podemos utilizar a **Classificação de Eron** para nos ajudar a definir a conduta ideal diante de um caso de celulite (e pode ser utilizada para pacientes com erisipela). Tal classificação avalia a presença de sinais de toxicidade sistêmica e comorbidades.



ABORDAGEM

Classe	Toxicidade sistêmica	Comorbidades	Antibióticos orais vs. parenterais	Tratamento internado ou ambulatorial
I	Sem sinais	Nenhuma	Oral	Ambulatorial
II	Duvidoso	Doença vascular periférica, obesidade ou insuficiência venosa	Intravenoso	Internação por 48 horas com antibiótico parenteral e alta com terapia parenteral ambulatorial
III	Toxicidade significativa: confusão, taquicardia, taquipneia ou hipotensão	Instáveis	Intravenoso	Hospitalar
IV	Sepse grave ou fascíte necrotizante	Instáveis	Intravenoso com possível debridamento cirúrgico	Hospitalar

Classificação de Eron - Adaptada de Medicina de Emergência FMUSP 17ª Edição.



ROTINA CLÍNICA

ABORDAGEM

- Avaliar o risco de infecção por *S. aureus* **resistente à meticilina** (MRSA) também é fundamental. Verifique se os fatores de risco estão presentes para promover a terapia mais adequada para o seu paciente.



ABORDAGEM

Fatores para considerar cobertura de agentes meticilino-resistentes (MRSA)

Hospitalização recente

Moradores em instituição de longa permanência

Cirurgia recente

Hemodiálise

Colonização conhecida por agente MRSA ou infecção anterior por MRSA

Contato próximo recente com uma pessoa colonizada ou infectada por MRSA

Infecção pelo HIV

Uso de drogas injetáveis

Homens que fazem sexo com homens

Uso de antibióticos nos últimos 6 meses

Exposições ambientais associadas a surtos de abscessos cutâneos por MRSA

Prisioneiros

Compartilhamento de agulhas, lâminas de barbear ou outros objetos pontiagudos

Fatores de risco para MRSA - Adaptado de Medicina de Emergência FMUSP 17ª Edição.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- O tratamento, em geral, tem duração de **5 a 14** dias e deve ser realizado conforme a indicação de internação e o risco de MRSA.
- **Atenção!!** Sempre devemos prescrever sintomáticos. Destaque para analgesia otimizada. Podemos utilizar (e associar) Dipirona, Paracetamol, AINEs ou Opioides em caso de dor moderada/intensa.
- No que se refere aos cuidados locais, recomendamos **higienização diária (2x ao dia) da lesão apenas com água e sabão neutro**. Lesões complexas devem ser avaliadas com cautela. A terapêutica deve ser individualizada.



TRATAMENTO

- **Paciente sem indicação de internação hospitalar e SEM risco de MRSA:**

Uso Oral:

Amoxicilina+Clavulanato 875 + 125 mg

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 7 dias.

Ou

Amoxicilina+Clavulanato 500 + 125 mg

Tomar 1 comprimido de 8/8h por 7 dias.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- **Paciente sem indicação de internação hospitalar e SEM risco de MRSA:**

Uso Oral:

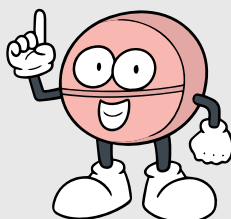
Cefalexina 500 mg ---- 1 Caixa

Tomar 1 comprimido de 6/6h por 7 dias.

Ou

Cefadroxila 500 mg ---- 1 Caixa

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 7 dias.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- **Paciente sem indicação de internação hospitalar e COM risco de MRSA ou alergia a beta-lactâmicos:**

Uso Oral:

Sulfametoxazol+Trimetoprim 800/160 mg

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 7 dias.

Ou

Doxiciclina 100 mg ---- 1 Caixa

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 7 dias.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- **Paciente com indicação de internação hospitalar e SEM risco de MRSA ou alergia a beta-lactâmicos:**

Uso endovenoso:

Cefazolina 1g F/A

Reconstituir em 10 mL de AD. Diluir em 100 mL de SF 0,9% e infundir em 60 minutos de 8/8h por 5 a 14 dias.

Ou

Ceftriaxona 1g F/A (dose habitual: 2g/dia)

Reconstituir cada frasco em 10 mL de água destilada. Diluir em 100 ml de soro fisiológico 0,9% e infundir em 30 minutos a 1 hora uma vez ao dia por 5 a 14 dias.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- **Paciente com indicação de internação hospitalar e SEM risco de MRSA ou alergia aos beta-lactâmicos:**

Uso endovenoso:

Oxacilina 500mg F/A (dose: 2 g de 4/4h)

Reconstituir cada 500 mg em 5 mL de AD ou SF 0,9%. Diluir em 100 mL de SF 0,9% e infundir em 60 minutos de 4/4h por 7 a 14 dias.

* Utilizar apenas em caso de celulite.

- **Paciente com indicação de internação hospitalar e risco de MRSA ou alergia aos beta-lactâmicos:**

Uso endovenoso:

Clindamicina injetável 600mg F/A

Não é necessário reconstituição. Diluir em 100 mL de SF 0,9% e infundir em 60 minutos, de 8/8h por 7 a 14 dias.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- **Paciente COM indicação de internação hospitalar e risco de MRSA ou alergia aos beta-lactâmicos:**

Uso endovenoso:

Linezolid 600mg injetável 2 mg/mL

Não é necessário reconstituição. Infundir em 60 minutos de 12/12h por 7 a 14 dias.

Ou

Vancomicina 500 mg (dose 1g de 12/12h)

Reconstituir cada 500 mg em 10 mL de AD.

Diluição varia conforme a dose entre 250 a 500 mL de SF 0,9% e infundir em 60 (tempo mínimo) a 90 minutos de 12/12h por 7 a 14 dias.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- Vale citar alguns **detalhes relevantes** de nossa prática clínica:
- Em geral, **NÃO** se recomenda “romper” bolhas no caso de erisipelas bolhosas. Vale citar que tal condição tende a apresentar maior tempo de internação quando comparada com erisipela sem bolhas. Cada caso deve ser abordado de forma individualizada.
- A duração do tratamento citada neste material de apoio segue a recomendação de referências atuais e consolidadas, porém, a **experiência** clínica do médico e a **evolução** do paciente (clínica e laboratorial) são fundamentais para determinar o tempo exato de tratamento.



TRATAMENTO

- Vale citar alguns **detalhes relevantes** de nossa prática clínica:
- É possível **descalonar** a terapia parenteral (EV) para VO quando o paciente apresenta resposta clínica e laboratorial positiva e sustentada. Em geral, recomendamos, pelo menos, 48 a 72h** de terapia EV, para posteriormente considerar o descalonamento caso haja **condições favoráveis** para tal.
- Sempre oriente cuidados locais com a lesão. O principal cuidado é a higienização apenas com água e sabão neutro. Recomenda-se evitar manipulação e uso de outras substâncias no local.



TRATAMENTO

- Vale citar alguns **detalhes relevantes** de nossa prática clínica:
- Alguns serviços (em geral, hospitais) apresentam **protocolos institucionais** no que se refere ao uso dos antimicrobianos para determinadas infecções. Dentre os serviços onde trabalhamos, a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) **RECOMENDAVA** esquema com **Ceftriaxona 2g/dia + Vancomicina 15 mg/kg/dose de 12/12h** para os pacientes internados com infecções de pele e partes moles.



ROTINA CLÍNICA

ESCABIOSE

- “**Bônus do bônus**”:
- É causada pelo patógeno (ácaro) *Sarcoptes scabiei var. hominis*.
- **Prurido** é a principal manifestação clínica. Vale citar que o prurido tende a piorar no período noturno ou após banhos com água quente.
- As lesões cutâneas se apresentam como **pápulas** eritematosas, presença de pequenas crostas e escoriações. Também podemos encontrar os famosos “**túneis**”, lesões lineares milimétricas com presença de pequena vesícula-pápula.



ESCABIOSE



Túnel Escabiotico

Imagens retiradas de: Scabies: Epidemiology, clinical features, and diagnosis - UpToDate



ROTINA CLÍNICA

ESCABIOSE

- **Tratamento para adultos:**
- **Ivermectina 6 mg/comprimido:** A dose recomendada é de **200 mcg** por kg (conforme UpToDate e Whitebook), com nova dose após 7 (recomendamos este intervalo) a 14 dias. Na prática, como cada comprimido de Ivermectina tem 6 mg, podemos prescrever **6 mg ou 1 comprimido para cada 30 kg** de peso corporal do paciente.
- Algumas referências recomendam associar a **terapia tópica** com Permetrina. Especificamos detalhes na página seguinte.



ESCABIOSE

- **Tratamento para adultos:**
- **Permetrina 5% loção ou creme:** aplicar no corpo todo (evitar a região cefálica), antes de dormir. Recomenda-se realizar por 1 única noite ou até 3 noites consecutivas. Remover o produto no banho pela manhã e repetir em 7 dias.
- Deve-se tratar os **contactantes e parcerias sexuais**.
- **Evitar nova contaminação:** trocar as roupas de cama, banho e a do corpo (usadas no dia do tratamento e nos dias anteriores). Fazer isso diariamente por 3 dias.



ESCABIOSE

- **Tratamento para adultos:**
- Lavar as roupas e deixá-las expostas ao sol. Existem referências que recomendam “ferver” as roupas em panela ou utilizar ferro de passar.
- Lembre-se sempre de prescrever sintomáticos! Neste caso, recomendamos **anti-histamínicos** para controle adequado do prurido.



ROTINA CLÍNICA

TINEA CORPORIS

- Infecção cutânea superficial causada por **fungos** dermatófitos.
- **Prurido** e **sensação de “ardor/queimação”** são as manifestações mais comuns.
- As lesões se apresentam como **pápulas** e/ou **placas** isoladas, ou confluentes com **bordas eritematosas** com área de clareamento central.
- Também podem ser descritas como lesões **bem delimitadas, circunscritas**, ovais ou circulares, levemente eritematosas, escamosas, com borda frontal elevada.



TINEA CORPORIS



Imagens retiradas de: Dermatophyte (tinea) infections - UpToDate



ROTINA CLÍNICA

TINEA CORPORIS

- **Tratamento para adultos:**
- Antifúngicos **tópicos** são indicados para tinea localizada (1ª linha de tratamento). Deve ser associado antifúngico sistêmico nos outros casos (infecções extensas, pacientes imunossuprimidos, entre outros casos).
- Em geral, tratar por **2 a 4 semanas** ou por, pelo menos, duas semanas após a melhora clínica completa.
- **NÃO** é recomendado o uso de corticoide tópico.



TINEA CORPORIS

- **Tratamento para adultos:**
- **Cetoconazol 2%, Miconazol 2% ou Clotrimazol 1%** (existem diversas outras opções). Aplicar fina camada sobre a lesão, 2 vezes ao dia (recomenda-se após o banho, com a pele seca), por 2 a 4 semanas ou por até 2 semanas após a melhora completa da lesão.
- A terapia sistêmica, quando indicada, pode ser realizada com **Fluconazol**. UpToDate recomenda 150** (mais utilizado, pois é a apresentação do comprimido no Brasil) a 200 mg, uma vez por semana, por 2 a 4 semanas.



REFERÊNCIAS

- Infecções cutâneas - Medicina de Emergência FMUSP 17ª Edição.
- Acute cellulitis and erysipelas in adults: Treatment - UpToDate.
- Cellulitis and skin abscess: Epidemiology, microbiology, clinical manifestations, and diagnosis - UpToDate.
- Infecções bacterianas superficiais cutâneas - SBP.
- Infecção de pele e partes moles - CREMESP 2013.
- Scabies: Management - UpToDate.
- Whitebook.
- Dermatophyte (tinea) infections - UpToDate.



ROTINA CLÍNICA